MANUAL DEFINITIVO DE VULVOVAGINITES E VAGINOSES

Fisiopatologia, Propedêutica, Diagnóstico Diferencial, Manejo em Gestantes e Diretrizes FEBRASGO 2025

1. MICROBIOMA VAGINAL, EUBIOSE E O PARADOXO GESTACIONAL

O ecossistema vaginal em estado de **eubiose** é predominantemente colonizado por bactérias do gênero *Lactobacillus* (destacando-se *L. crispatus*, *L. gasseri*, *L. jensenii* e *L. iners*). Sob estímulo do estrogênio, as células do epitélio vaginal sintetizam e acumulam elevados teores de **glicocênio**. Os lactobacilos metabolizam a glicose proveniente do glicogênio, produzindo **ácido lático**, responsável por manter o **pH vaginal fisiologicamente ácido, entre 3,8 e 4,5**. Adicionalmente, os lactobacilos produzem peróxido de hidrogênio (H_2O_2), bacteriocinas e biossurfactantes, constituindo a barreira primária contra patógenos oportunistas.

O Paradoxo Imunológico e Microbiológico na Gestação: Durante o ciclo gravídico, o estado de intenso **hiperestrogenismo** promove uma deposição massiva de glicogênio na mucosa vaginal. Isso causa uma superproliferação de lactobacilos e uma acidificação extrema do meio vaginal (pH comumente ≤ 4,0). Embora esse ambiente hiperácido proteja eficazmente contra a proliferação de bactérias anaeróbias (reduzindo o risco de vaginose bacteriana), ele gera um *paradoxo*: a gestante torna-se extraordinariamente susceptível à **Candidíase Vulvovaginal** e à **Vaginose Citolítica**. Esse quadro é amplificado pelas adaptações de imunotolerância materna no sítio de implantação.

2. PROPEDÊUTICA CLÍNICA: A TRÍADE DIAGNÓSTICA DE CONSULTÓRIO

A conduta baseada unicamente no aspecto visual da leucorreia ('olhômetro') ou na sintomatologia isolada apresenta taxas de erro superiores a 50%. A FEBRASGO preconiza a realização obrigatória da **Tríade Diagnóstica de Consultório** em todas as consultas ginecológicas com queixa de corrimento:

- **1. Medição do pH Vaginal:** Realizada com fita indicadora posicionada no terço médio da parede vaginal lateral (evitando o muco cervical e sangue). É o *divisor de águas* clínico: pH ≤ 4,5 orienta para Candidíase ou Vaginose Citolítica; pH > 4,5 indica Vaginose Bacteriana, Tricomoníase, Vaginite Aeróbia ou Atrofia.
- **2. Teste das Aminas / Whiff Test (KOH 10%):** Adiciona-se uma gota de KOH a 10% sobre a secreção vaginal em lâmina. A alcalinização volatiliza diaminas aromáticas (putrescina e cadaverina) produzidas pelo metabolismo de anaeróbios, liberando odor fétido de 'peixe podre'. Tipicamente positivo na Vaginose Bacteriana e Tricomoníase.
- **3. Microscopia a Fresco e Corada (Gram):** Exame direto da secreção diluída em solução salina morna (permite visualizar protozoários móveis de *Trichomonas*, *clue cells* e leucócitos) e corada pelo Gram (estudo dos morfotipos de *Lactobacillus*, escore de Nugent e hifas de *Candida*).

3. VAGINOSE BACTERIANA (VB)

A Vaginose Bacteriana é a causa mais prevalente de disbiose vaginal em mulheres em idade fértil. Caracteriza-se pela substituição maciça dos *Lactobacillus* por uma flora anaeróbia e facultativa complexa (incluindo *Gardnerella spp.*, *Atopobium vaginae*, *Prevotella*, *Mobiluncus* e *Mycoplasma hominis*). As bactérias organizam-se em uma matriz polissacarídica altamente aderente às células epiteliais — o **biofilme bacteriano** —, o qual confere resistência aos mecanismos imunes e aos tratamentos convencionais, sendo o motor das recorrências.

Critérios Diagnósticos de Amsel (requer pelo menos 3 dos 4):

- Corrimento vaginal fluido, homogêneo, branco-acinzentado, finamente bolhoso e aderente às paredes.
- pH vaginal acentuadamente elevado (pH > 4,5).
- Teste das Aminas (Whiff Test) positivo com desprendimento de odor fétido ao KOH 10%.
- Presença de *Clue Cells* (células-alvo/chave) correspondendo a ≥ 20% das células escamosas na microscopia.

Escore de Nugent (Padrão-Ouro Laboratorial): Avalia a bacterioscopia corada pelo Gram. Escore 0 a 3: Microbiota Normal (lactobacilos dominantes); Escore 4 a 6: Microbiota Intermediária; **Escore 7 a 10: Vaginose Bacteriana Confirmada**.

> **ALERTA DE TRATAMENTO DA VB:**
> • **Não-Gestantes:** Metronidazol 500 mg VO de 12/12h por 7 dias; OU Metronidazol gel 0,75% intravaginal por 5 noites; OU Clindamicina creme 2% por 7 noites; OU Secnidazol 2g VO dose única.
> • **Gestantes: Metronidazol 500 mg VO de 12/12h por 7 dias**. O tratamento é obrigatório na gestação para prevenir parto pré-termo e amnionite.
> • **CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA:** O **Tinidazol é estritamente PROIBIDO na gestação** (Classe C FDA/risco teratogênico).
> • **Efeito Antabuse (Dissulfiram-like):** Orientar abstenção absoluta de álcool durante e até 24h após o término do Metronidazol.

4. CANDIDÍASE VULVOVAGINAL (CVV)

A Candidíase Vulvovaginal é uma vaginite inflamatória decorrente da transição comensal-patógeno de leveduras do gênero *Candida*. A **Candida albicans é responsável por 85% a 90% dos casos**. Espécies *não-albicans* (como *Candida glabrata*, *C. tropicalis* e *C. krusei*) correspondem a 10–15% dos episódios e apresentam resistência intrínseca ou adquirida aos derivados azólicos.

Quadro Clínico e Biomarcadores: Intenso **prurido vulvovaginal** (sintoma guia), acompanhado de corrimento esbranquiçado espesso em grumos com aspecto clássico de **'leite talhado' ou 'nata de leite'**, hiperemia, edema vulvar, fissuras e disúria terminal. Os sintomas exacerbam-se no período pré-menstrual. **pH vaginal mantido ÁCIDO (pH ≤ 4,5)** e **Whiff Test NEGATIVO**. A microscopia a fresco/KOH 10% demonstra hifas, pseudo-hifas e blastoconídeos.

> **REGRA DE OURO DA CANDIDÍASE NA GESTAÇÃO:**
> **ANTIFÚNGICOS ORAIS E ÁCIDO BÓRICO SÃO STRICTAMENTE PROIBIDOS EM GESTANTES!**
> • **Gestantes:** Tratamento EXCLUSIVAMENTE TÓPICO VAGINAL com azólicos por 7 dias (Miconazol creme 2% ou Clotrimazol creme 1% intravaginal à noite por 7 noites). Se infecção por *C. glabrata* em gestantes, utilizar **Nistatina creme por 14 noites** (pois o ácido bórico é teratogênico).
> • **Não-Gestantes:** Fluconazol 150 mg VO em Dose Única; ou esquemas tópicos por 7 a 14 dias.

5. TRICOMONÍASE: INFECÇÃO SEXUALMENTE TRANSMITIDA

A Tricomoníase é uma IST causada pelo protozoário flagelado móvel *Trichomonas vaginalis*. O organismo ataca o epitélio vaginal provocando uma violenta resposta inflamatória tecidual com microerosões vasculares.

Quadro Clínico e Sinal Patognomônico: Corrimento profuso, abundante, **amarelo-esverdeado, bolhoso** e de odor fétido. Cursa com intenso ardor, dispareunia e disúria. Os sintomas pioram no período pós-menstrual. Ao exame especular, observa-se o clássico **'Colo em Morango / Framboesa' (colpitis macularis)**, decorrente das múltiplas sufusões hemorrágicas no colo. **pH vaginal alcalino (pH > 5,0)** e Whiff Test frequentemente positivo. A microscopia a fresco revela protozoários piriformes vivos realizando movimentos pendulares ativos.

REGRAS OBRIGATÓRIAS DA TRICOMONÍASE:
1. **Tratamento Mandatório da Parceria Sexual:** O parceiro deve ser tratado obrigatoriamente, mesmo se assintomático.
2. **Rastreamento Compulsório de Outras ISTs:** Solicitar sorologias para Sífilis, HIV, Hepatite B, Hepatite C e pesquisa de Clamídia/Gonococo.
• **Tratamento Não-Gestante:** Metronidazol 2g VO Dose Única; OU Tinidazol 2g VO Dose Única.
• **Tratamento Gestante:** Metronidazol 500 mg VO de 12/12h por 7 dias. (Tinidazol contraindicado).

6. VAGINOSE CITOLÍTICA

A Vaginose Citolítica é uma afecção não-infecciosa decorrente do supercrescimento de *Lactobacillus*, levando à **hiperacidez extrema (pH ≤ 4,0)**. Essa acidez excessiva provoca a destruição e lise das células epiteliais intermediárias (citólise), liberando conteúdo citoplasmático e gerando sintomas idênticos aos da Candidíase: prurido, ardor e corrimento em grumos com exacerbação na fase lútea/pré-menstrual. A microscopia revela lactobacilos abundantes, ausência de fungos e múltiplos **núcleos celulares desnudos**. **Tratamento:** Banho de assento/duchas com **Bicarbonato de Sódio** (alcalinização do meio). O uso de antifúngicos é inócuo.

7. VAGINITE AERÓBIA E VAGINITE INFLAMATÓRIA DESCAMATIVA (VID)

Decorre da substituição da microbiota por bactérias aeróbias entéricas (*Escherichia coli*, *Streptococcus agalactiae*/GBS e *Staphylococcus aureus*). A VID representa a forma máxima da vaginite aeróbia, caracterizando-se por intensa inflamação tecidual, corrimento purulento profuso, equimoses e erosões vaginais. O pH é > 5,5 e a microscopia demonstra ausência de lactobacilos, abundância de leucócitos tóxicos e células epiteliais parabasais. **Tratamento Prolongado:** Clindamicina creme 2% associada a corticoide tópico (Hidrocortisona) por 2 a 4 semanas na indução e manutenção por 2 a 6 meses.

8. CASOS CLÍNICOS PRÁTICOS ILUSTRATIVOS

Caso 1: Vaginose Bacteriana na Gestação

Gestante, 24 semanas, assintomática, apresenta em exame de rotina corrimento fluido acinzentado, pH 5,2, Whiff test positive e 25% de clue cells. **Conduta:** Prescrever Metronidazol 500 mg VO de 12/12h por 7 dias. O tratamento previne rotura prematura de membranas e prematuridade.

Caso 2: Erro Terapêutico em Candidíase Gestacional

Gestante de 18 semanas com prurido vulvar intenso e corrimento em nata de leite. O médico prescreveu Fluconazol 150 mg VO. **Análise Crítica:** Conduta errônea e perigosa. Antifúngicos orais são contraindicados na gestação. O correto é Miconazol creme 2% intravaginal por 7 noites.

Caso 3: Tricomoníase e Manejo do Parceiro

Paciente de 28 anos com corrimento amarelo-esverdeado fétido, disúria e 'colo em morango' ao exame especular. pH 5,5 e protozoários móveis a fresco. **Conduta:** Metronidazol 2g VO dose única para a paciente e convocação compulsória do parceiro para tratamento com a mesma dose, além de painel de ISTs.

Caso 4: Vaginose Citolítica Falsamente Diagnosticada como Candidíase

Paciente de 30 anos refere prurido e corrimento em grumos pré-menstrual recorrente. Usou fluconazol 4 vezes sem melhora. pH 3,6, sem hifas, com excesso de lactobacilos e núcleos desnudos. **Conduta:** Suspender antifúngicos e iniciar banho de assento com Bicarbonato de Sódio para alcalinização.

Caso 5: Candidíase Recorrente por Candida glabrata

Paciente com episódios fúngicos de repetição que não respondem ao fluconazol. Cultura identificou *Candida glabrata*. **Conduta:** Prescrever Óvulos de Ácido Bórico 600 mg por via vaginal por 14 dias (em não-gestantes) ou Nistatina creme.

Caso 6: VB Recorrente com Biofilme Persistente

Paciente com 5 episódios de VB no ano. Apresenta biofilme bacteriano estruturado. **Conduta:** Metronidazol gel por 10 dias na indução, seguido de terapia de manutenção com Metronidazol gel 2 vezes por semana por 4 a 6 meses.

Caso 7: Vaginite Inflamatória Descamativa na Pós-Menopausa

Mulher de 58 anos com corrimento purulento, dispareunia severa e erosões vaginais. Uso prévio de estrogênio tópico sem melhora. Microscopia com células parabasais e leucócitos tóxicos. **Conduta:** Clindamicina creme 2% + Hidrocortisona tópica por 3 semanas.

Caso 8: Alerta de Efeito Antabuse em Paciente Etilista

Paciente com VB necessita de tratamento, mas relata consumo diário de cerveja. **Conduta:** Optar por Clindamicina creme 2% por 7 noites para evitar a reação antabuse do Metronidazol oral com o álcool.

Caso 9: Tricomoníase como Sinalizador de Outras ISTs

Paciente com diagnóstico de *Trichomonas vaginalis* submetida ao painel compulsório de ISTs. Sorologia VDRL resultou positiva (1:16). **Conduta:** Tratamento da Tricomoníase e início imediato do tratamento para Sífilis secundária com Penicilina Benzatina.

Caso 10: Vulvovaginite Fúngica Pós-Antibioticoterapia

Paciente desenvolveu prurido e leucorreia em grumos 3 dias após finalizar amoxicilina com clavulanato para sinusite. **Fisiopatologia e Conduta:** A antibioticoterapia eliminou os lactobacilos protetores. Tratamento com Fluconazol 150 mg VO em dose única.

9. TABELAS RESUMO PARA MEMORIZAÇÃO RÁPIDA

Tabela 1: Matriz de Diagnóstico Diferencial das Vulvovaginites e Vaginoses

Condição	Aspecto do Corrimento	pH Vaginal	Whiff Test	Microscopia Chave	Tratamento de Escolha
Vaginose Bacteriana	Fluido, homogêneo, branco-acinzentado	> 4,5	POSITIVO (+)	Clue cells (≥20%), ausência de leucócitos	Metronidazol 500mg VO 12/12h 7d
Candidíase Vulvovaginal	Espesso, em grumos ('leite talhado')	≤ 4,5	NEGATIVO (-)	Hifas, pseudo-hifas e esporos	Fluconazol 150mg VO DU (Não-Gestante)

Condição	Aspecto do Corrimento	pH Vaginal	Whiff Test	Microscopia Chave	Tratamento de Escolha
Tricomoníase	Profuso, amarelo-esverdeado, bolhoso	> 5,0	Frequente (+)	Protozoário móvel + 'Colo em Morango'	Metronidazol 2g VO DU + Tratar Parceiro
Vaginose Citolítica	Grumoso ou fluido, esbranquiçado	≤ 4,0	NEGATIVO (-)	Excesso de lactobacilos + núcleos desnudos	Duchas/Banhos de Bicarbonato de Sódio
Vaginite Inflamatória (VID)	Purulento, profuso, amarelo-ouro	> 5,5	NEGATIVO (-)	Leucócitos tóxicos + células parabasais	Clindamicina 2% + Hidrocortisona tópica

Tabela 2: Manejo Terapêutico Comparativo — Gestantes vs. Não-Gestantes

Patologia	Conduta em Não-Gestantes	Conduta em Gestantes	Contraindicações Absolutas na Gestação
Vaginose Bacteriana	Metronidazol 500mg VO 12/12h 7d OU Secnidazol 2g VO DU OU Clindamicina creme 7d	Metronidazol 500mg VO 12/12h por 7 dias	TINIDAZOL é estritamente PROIBIDO (teratogênico)
Candidíase Vulvovaginal	Fluconazol 150mg VO Dose Única OU Imidazólico Tópico 7d	Imidazólico Tópico (Miconazol/Clotrimazol) por 7 noites	ANTIFÚNGICOS ORAIS E ÁCIDO BÓRICO SÃO PROIBIDOS
Tricomoníase	Metronidazol 2g VO Dose Única OU Tinidazol 2g VO DU	Metronidazol 500mg VO de 12/12h por 7 dias	Tinidazol contraindicado; Tratar parceiro obrigatório